



การคัดกรองและติดตาม กลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง จังหวัดอุบลราชธานี

นางสาววรรณภา สะดีวงศ์
พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี





9 นโยบายการพัฒนาางานสุขภาพจิต ประจำปีงบประมาณ 2568



นายแพทย์กิตติศักดิ์ อักษรวงศ์ อธิบดีกรมสุขภาพจิต

พัฒนาผลิตภัณฑ์ บริการ และความเชี่ยวชาญ
ด้านสุขภาพจิตที่ตอบโจทย์
ความท้าทายของสังคมอนาคต
(New S-Curve of Mental Health)

พัฒนาระบบบริการวิกฤตสุขภาพจิต
ที่มีความคล่องตัว รวดเร็ว
พร้อมตอบโต้ภาวะวิกฤตและฉุกเฉิน
ในทุกรูปแบบ

เสริมสร้างความรอบรู้
ด้านสุขภาพจิต
และสารเสพติดให้ทุกกลุ่มวัย

ส่งเสริม ป้องกัน
ปัญหาสุขภาพจิตเด็กและเยาวชน



สถานการณ์ผู้ป่วยจิตเวชยาเสพติดก่อความรุนแรง (SMI-V)

Social Listening เฝ้าระวังข่าวความรุนแรง
กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข



60%

ปัญหาสังคม
ทะเลาะวิวาท
ขัดผลประโยชน์
ความสัมพันธ์ในครอบครัว



40%

ข่าวความรุนแรงที่
เกี่ยวข้องกับผู้ป่วย
จิตเวชหรือ ยาเสพติด

40%

ผู้ป่วยจิตเวช
ไม่เสพยา

30%

ผู้ป่วยอื่น
(แอลกอฮอล์)

30%

ผู้ป่วยยาเสพติด
หรือจิตเวช
ยาเสพติด

223,253 ประเมินการณ์ผู้ป่วย SMI-V

33.57% อัตราการเข้าถึงบริการ SMI-V

สาเหตุความรุนแรง

- หลงผิดประสานหลอนจากจิตเวชหรือยาเสพติดหรือแอลกอฮอล์
- รับการรักษาไม่ต่อเนื่อง ไม่ร่วมมือในการรักษา
- กลับไปเสพยาซ้ำ จนอาการกำเริบ

V-Care: ข้อเสนอการใช้งานเพื่อลดความรุนแรง



ค้นหากลุ่มเป้าหมาย

- เฝ้าระวัง/คัดกรองประชาชน อายุ 15-50 ปี ด้วย 5 สัญญาณเตือน
- อาจเริ่มที่ผู้ชายก่อน



ติดตามกลุ่มเสี่ยงสูง

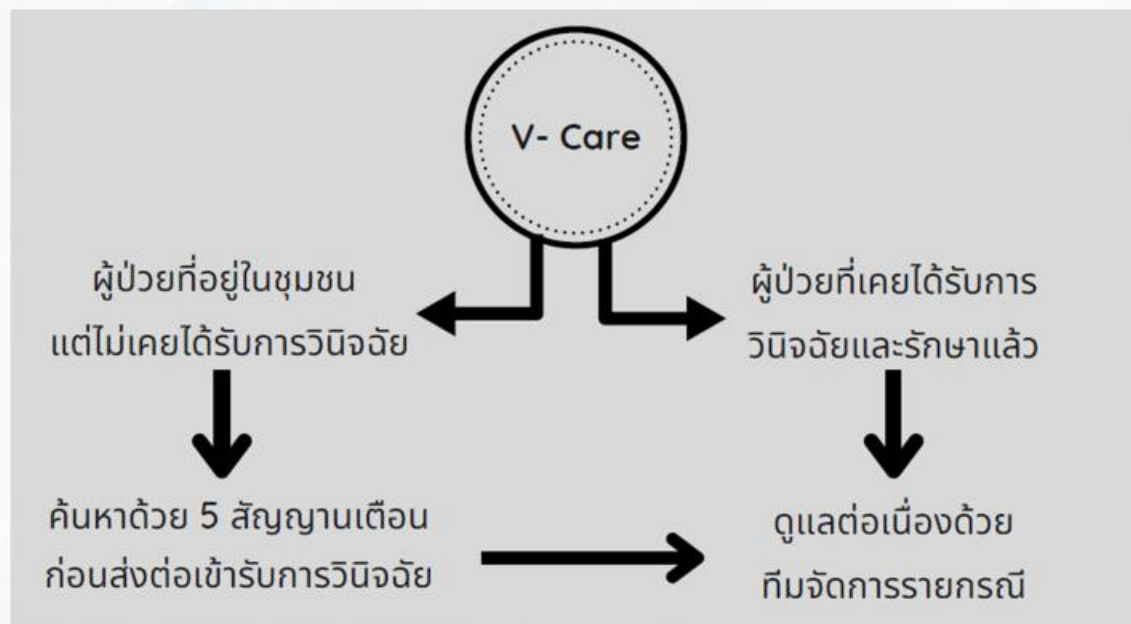
- เร่งติดตาม SMI-V 2-3-4 ขาดการรักษา (ทำร้ายผู้อื่น - หลงผิดบุคคลสำคัญ - คดีอุกฉกรรจ์)



อนุกรรมการจังหวัด

- นำเสนอข้อมูล SMI-V โดย นพ.สสจ. ในคณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด เพื่อ มท/ตร ร่วมติดตามเคส และ ผู้ว่าราชการจังหวัดกำกับติดตาม

ระบบการดูแลผู้ป่วยจิตเวชกลุ่มเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง (V-Care)



ทีมจัดการรายกรณี : ประกอบด้วย บุคลากรสาธารณสุขระดับ sw.สต.ขึ้นไป ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงานด้านสังคมที่ พมจ. มอบหมาย ร่วมกับ ผู้ปฏิบัติงานด้านความมั่นคง เช่น ท้องถิ่น ตำรวจ ฯลฯ
ทีมใช้ข้อมูลจากชุมชนร่วมกันก่อน หากจำเป็นจึงประสานข้อมูลตามมาตรา 16(2) เพื่อความปลอดภัยของสาธารณชน

คณะอนุกรรมการสุขภาพจิตระดับจังหวัด

กลไกขับเคลื่อน: การผสานพลังเครือข่ายบูรณาการ 4 ภาคส่วน

ศูนย์กลางการแลกเปลี่ยนข้อมูลความเสี่ยงร่วมกัน
เพื่อความปลอดภัยของสังคมและผู้ป่วย



พลังความร่วมมือ: เครือข่ายไร้รอยต่อ ลดความรุนแรงซ้ำอย่างยั่งยืน



ด้วยระบบข้อมูล **V-Care** ที่เชื่อมโยง โครงสร้างพื้นฐานที่ครอบคลุม และการทำงานร่วมกันของทีมสหวิชาชีพ
จังหวัดอุบลราชธานีมีความพร้อมเต็มพิกัดในการบรรลุเป้าหมายการดูแลต่อเนื่อง
($\geq 40\%$) และมอบความปลอดภัยสูงสุดคืนสู่ชุมชน

© NotebookLM



ประสานส่งคืนข้อมูลระหว่าง sw.สต. ทุกแห่ง
เพื่อติดตามผู้ป่วย V2-V4 อย่างต่อเนื่องไร้รอยต่อ

มีคำสั่งแต่งตั้ง "ผู้จัดการข้อมูล" ระดับจังหวัด
เพื่อรักษาความลับตามกฎหมายวิชาชีพขั้นสูงสุด

นำข้อมูล SMI-V เข้าสู่วาระการประชุมคณะอนุกรรมการ
สุขภาพจิตจังหวัดอุบลราชธานี ปี 2569

มาตรการการดูแลประชาชน ภายใต้โครงการ "อสม.ใกล้ขีด ช่วยคิด ช่วยคัดกรอง SMI-V"

การค้นหา เฝ้าระวัง สัญญาณเตือน ผู้ที่มีความเสี่ยงต่อการก่อความรุนแรง SMI-V SCAN



หากพบเห็นบุคคล มีอาการเหล่านี้อย่างน้อย 1 ข้อ
แจ้ง **191** หรือ **1669**
เพื่อนำส่งเข้ารับการดูแล วินิจฉัยในโรงพยาบาลใกล้บ้าน

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

7 สัญญาณเตือนก่อความรุนแรง กลุ่มเฝ้าระวังและติดตามในชุมชน

ญาติ คนใกล้ชิด ประชาชนทั่วไป ผู้นำชุมชน และอสม./อสส.
“ต้องคอยเฝ้าระวัง สังเกตสัญญาณเตือนเหล่านี้”
พบ **1** สัญญาณเตือนขึ้นไป โทร **191** หรือ **1669**

-
1. ชิดชวนตัวเอง เป็นรอยแผล
 2. ช่มชู่จะทำร้ายผู้อื่น
 3. ด่าหยาบคาย รุนแรง
 4. ทำร้ายผู้อื่น จนบาดเจ็บ
 5. ทำลายสิ่งของ แตกหัก
 6. ขว้างปาข้าวของ กระจัดกระจาย
 7. พกพาอาวุธ ไม่สมเหตุ

ถ้ามี “สัญญาณเตือน” เหล่านี้ ญาติ ผู้ใกล้ชิดหรือผู้พบเหตุ
“ แจ้งชุดปฏิบัติการตำบล/อำเภอ
ประเมินผู้ป่วยและสถานการณ์ เคลื่อนย้ายผู้ป่วยให้สงบ ”
หากมีแนวโน้มรุนแรงประสาน **191** หรือ **1669**
ควบคุมสถานการณ์ และให้การช่วยเหลือนำส่ง
โรงพยาบาลใกล้บ้าน ต่อไป

สายด่วนสุขภาพจิต **1323** บริการออนไลน์

กลุ่มงานควบคุมโรคไม่ติดต่อ สุขภาพจิตและยาเสพติด สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี

SYSTEM JOURNEY

การคัดกรองเคส แอป วีแคร์ (V care)

1

พบเห็น**ประชาชน**
ที่ใช้ความรุนแรง



ได้รับแจ้งหรือพบเห็นคนที่มีพฤติกรรม
เสี่ยงที่จะก่อความรุนแรงในคนที่ไม่เคย
ได้รับการตรวจหรือรักษาอาการทาง
สุขภาพจิตจากแพทย์

ประเมินจากการพบเห็น

2

สอบถามและประเมิน
5 สัญญาณเตือน



สอบถามประวัติในอดีต โดยถาม
ญาติหรือคนที่รู้จักเคสกลุ่มเสี่ยง

ประเมิน 5 สัญญาณเตือน

3

ลงพื้นที่

โดย ทีมปกครอง+ทีม sw.สต.



ทีม sw.สต. ร่วมกับทีมฝ่าย
ปกครองของพื้นที่เสมอเพื่อ
ความปลอดภัย

ประเมินเคสด้วย OAS

4

ทีมสหกระทรวง
ร่วมกันติดตาม เยี่ยมเคส



ทุกภาคส่วนร่วมติดตาม
เยี่ยมบ้านเคส หลังจากได้รับ
การรักษา

แบบประเมิน 4 ด้าน

ขับเคลื่อน โดยโครงการ “ อสม.ใกล้ขีด ช่วยคิด ช่วยคัดกรอง SMI-V ”



การแปลผล

เขียว (เสี่ยงต่ำ)

มี 5 สัญญาณเตือนอย่างน้อย 1 ข้อ และ/หรือ มีประวัติป่วยด้านจิตเวช และ/หรือ มีประวัติการใช้สารเสพติดใน 1 เดือนที่ผ่านมา

เหลือง

เงื่อนไขเดียวกับกลุ่มเขียว และมีคะแนน OAS 1 คะแนน

ส้ม

เงื่อนไขเดียวกับกลุ่มเขียว และมีคะแนน OAS 2 คะแนน

แดง (เสี่ยงสูง)

เงื่อนไขเดียวกับกลุ่มเขียว และมีคะแนน OAS 3 คะแนน

A = ประชาชนที่ได้รับการคัดกรองด้วย V-CARE (5 สัญญาณเตือน)

B = ประชาชนที่พบความเสี่ยง (เขียว เหลือง ส้ม แดง)

C = ประชากรกลางปี อายุ 15 - 60 ปี (ข้อมูล พ.ศ. 2567)

ที่มา : Application V-CARE โรงพยาบาลจิตเวชนครราชสีมาราชสีมาราชนครินทร์ | ข้อมูล ณ วันที่ 18 มิถุนายน 2569

ตารางผลคัดกรองเทียบประชากรกลางปี

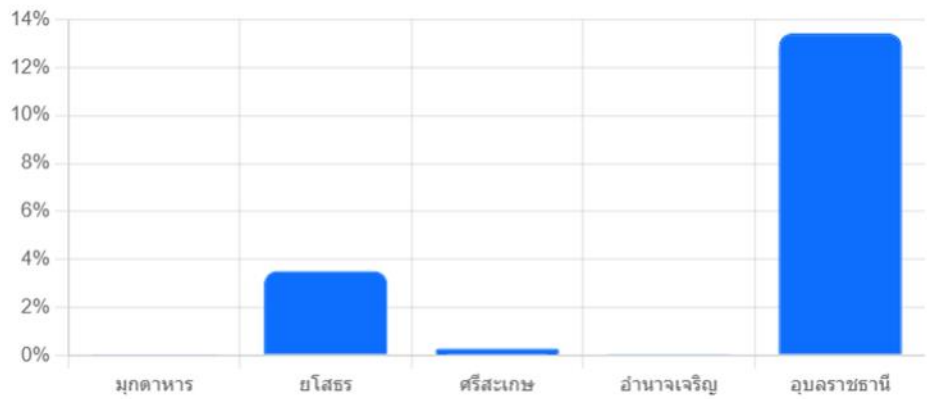
ทุกเขตสุขภาพ > เขตสุขภาพที่ 10

① **หมายเหตุ:** พื้นที่ที่แสดงจำนวนคัดกรองเป็น 0 หรือไม่ปรากฏในตาราง คือพื้นที่ที่ยังไม่มีการบันทึกข้อมูลในระบบ V-CARE คัดกรอง ภายใต้ช่วงเวลาและเงื่อนไขที่เลือก

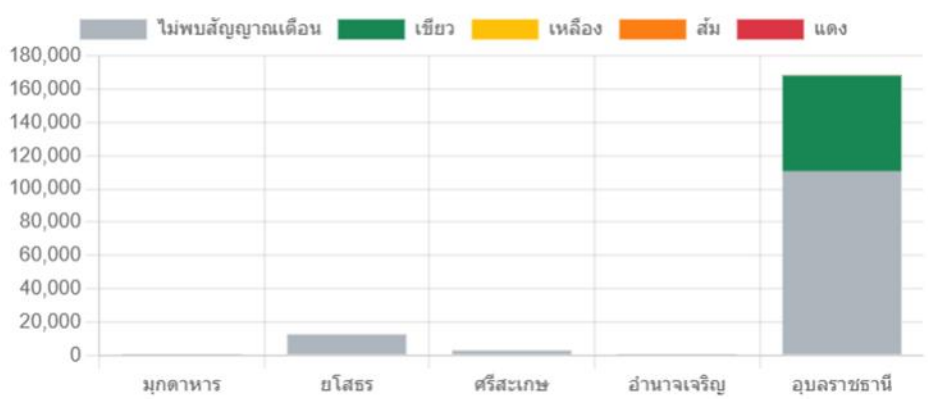
① ข้อมูลประชากรกลางปีมีถึงระดับจังหวัดเท่านั้น ระดับอำเภอและตำบลจะแสดงเฉพาะจำนวนผลคัดกรอง

พื้นที่	ประชากรกลางปี	คัดกรองทั้งหมด	Coverage %	ไม่พบสัญญาณเตือน	กลุ่มเสี่ยง	เขียว	เหลือง	ส้ม	แดง	Drill
มุกดาหาร	236,984	18	0.01%	18	0	0	0	0	0	→
ยโสธร	354,781	12,455	3.51%	12,200	255	102	17	27	109	→
ศรีสะเกษ	970,956	2,755	0.28%	2,530	225	186	16	16	7	→
อำนาจเจริญ	251,187	123	0.05%	106	17	16	0	1	0	→
อุบลราชธานี	1,255,746	168,624	13.43%	110,756	57,868	57,575	171	64	58	→
รวมทั้งหมด	3,069,654	183,975	5.99%	125,610	58,365	57,879	204	108	174	-

ร้อยละคัดกรองเทียบประชากรกลางปี



ผลคัดกรองจำแนกตามกลุ่ม



ผลการดำเนินงาน V-Care คัดกรอง

แสดงผลการดำเนินงานคัดกรอง V-Care เทียบประชากรกลางปี จำแนกตามเขตสุขภาพ จังหวัด อำเภอ และตำบล

Print

รูปแบบช่วงเวลา

☒ ปีงบประมาณ ☐ ช่วงวันที่

ปีงบประมาณ

ปีประชากรกลางปี

เขตสุขภาพ

จังหวัด

2569

▼

2567

▼

เขตสุขภาพที่ 10

▼

อุบลราชธานี

▼

ค้นหา

↺

ประชากรกลางปี

1,255,746

หน่วย: คน

คัดกรองทั้งหมด

168,624

ทุกกลุ่มผลคัดกรอง

ร้อยละคัดกรอง

13.43%

เทียบประชากรกลางปี

กลุ่มเสี่ยง

57,868

เบี่ยง + เหลือง + ส้ม + แดง

ไม่พบสัญญาณเตือน

110,756

เบี่ยง

57,575

เหลือง

171

ส้ม

64

แดง

58

ผลติดตามดูแลผู้ป่วยจิตเวชเรื้อรัง

ผลการติดตามดูแล 5 ด้าน แยกตามปีงบประมาณ เขตสุขภาพ และจังหวัด

Print

Excel

ปีงบประมาณ

เขตสุขภาพ

จังหวัด

2568



เขต 10



อุบลราชธานี



ค้นหา



ไควต้าที่ได้รับจัดสรร

493

หน่วย: ราย

จำนวนการลงทะเบียน จร.1

564

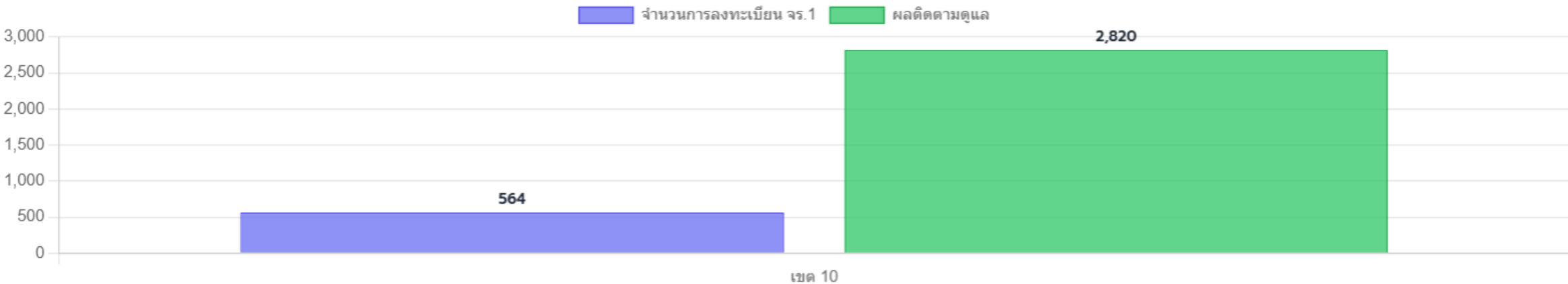
หน่วย: ราย

ร้อยละการติดตาม

100.00%

ร้อยละการติดตามต่อยอดลงทะเบียนทั้งหมด

ผลติดตามดูแลรายเขตสุขภาพ



ระบบการดูแล ติดตาม ต่อเนื่องในชุมชน



1. ใช้หลัก **2 ย (ยา ญาติ) และ 1 ส (สารเสพติด)** และติดตามเยี่ยมอาการตามการจำแนกประเภท
 - ประเมินปัจจัยเสี่ยง อาการเตือน 5 Red flag : ติดตามผู้ป่วยโรคจิตเภทเรื้อรังในชุมชน 4 ด้าน
 - ทีมสุขภาพจิตชุมชนออกเยี่ยมประเมินอาการตามแนวทางการจัดการผู้ป่วยรายกรณี (**case management**) ในชุมชน โดยมีทุกภาคส่วนเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแล
2. กรณีผู้ป่วยจิตเวชยุ่งยากซับซ้อนหรือมีอาการกำเริบซ้ำ ให้ทบทวน (Conference) ร่วมกับทีมสหวิชาชีพ
3. จัดทำแผนการดูแลรายบุคคล (Individual Care Plan)
4. รายงานผลการติดตามในระบบ V – Care ต่อเนื่อง



สิทธิการเข้าใช้งานโปรแกรม V-CARE





คืนความปลอดภัยสู่สังคมไทย

การคัดกรองที่รวดเร็ว การดูแลที่ไร้รอยต่อ
คือหัวใจสำคัญของระบบ **V-Care**

จังหวัดอุบลราชธานี



การดูแลผู้ป่วย SMI-V คือความรับผิดชอบร่วมกัน ของชาวอุบลราชธานี

จากวิกฤตสู่ความปลอดภัย...
ด้วยพลังบูรณาการของชุมชน

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี
พร้อมขับเคลื่อนเคียงข้างทุกภาคส่วน